

TEMA 2.11 • TRAUMATOLOGÍA

Lesiones de Partes Blandas

PERFIL EUNACOM 1.01.1.021

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Los tumores óseos son un tema de baja frecuencia en el EUNACOM, pero cuando aparecen, las preguntas suelen ser muy específicas sobre la **radiología**, la **edad del paciente** y la **localización anatómica**.

Generalidades y Clínica

La mayoría de los tumores óseos comparten una presentación clínica similar, lo que dificulta el diagnóstico basado únicamente en los síntomas. Los tres escenarios principales son:

- **Asintomáticos:** Hallazgo incidental en una radiografía solicitada por otro motivo (frecuente en tumores benignos).
- **Dolor:** Puede ser sordo, persistente o nocturno.
- **Fractura en hueso patológico:** El tumor debilita la cortical hasta que el hueso falla ante un traumatismo mínimo.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Para el diagnóstico diferencial en el examen, fíjate siempre en tres factores: 1. **Edad** del paciente. 2. **Localización** en el hueso (Epífisis, Metáfisis o Diáfisis). 3. **Aspecto radiológico** (Signos de benignidad vs. malignidad).

Diagnóstico Radiológico: Benigno vs. Maligno

La radiografía simple es la herramienta diagnóstica más potente. A diferencia de otros cánceres, la imagen aporta información casi definitiva sobre el comportamiento biológico de la lesión.

TABLA 2.11.1: CARACTERÍSTICA VS BENIGNO

CARACTERÍSTICA	BENIGNO	MALIGNO
Cortical	Respetada o adelgazada suavemente	Disrupción / Rotura de la cortical
Partes Blandas	No invadidas	Invasión de partes blandas
Límites	Bien delimitados, geográficos	Mal delimitados, infiltrativos, heterogéneos
Reacción Perióstica	Ausente o simple (sólida)	Compleja (Sol naciente, Telas de cebolla)

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

La **reacción perióstica compleja** es un signo de alta agresividad. - **Sol naciente (o en sol radiante):** Sugiere crecimiento rápido que levanta el periostio. - **Telas de cebolla:** Capas sucesivas de hueso reactivo, clásico del Sarcoma de Ewing.

Tumores Óseos Benignos y Pseudo-tumorales

1. Osteocondroma

Es el tumor óseo benigno más frecuente. - **Clínica:** Pacientes jóvenes. Suele ser asintomático o presentarse como un bulto óseo indoloro (aumento de volumen). - **Radiografía:** Imagen polipoidea, como un "hijo" o "cachito" de hueso que crece hacia afuera de la metáfisis. - **Tratamiento:** Observación. Solo se opera si genera compresión mecánica o dolor por roce.

2. Osteoma Osteoide

- **Clínica:** Jóvenes con **dolor nocturno característico que cede con Aspirina o AINEs**. - **Radiografía:** Lesión radiolúcida pequeña (nidus) rodeada de un halo de esclerosis (radiopaco), ubicada típicamente en la **cortical**. - **Tratamiento:** AINEs para el dolor. Si es refractario o muy grande, se plantea cirugía o ablación por radiofrecuencia.

3. Enfermedad de Paget (Osteítis Deformante)

Más que un tumor, es una patología del remodelado óseo de origen genético. - **Clínica:** Adultos mayores, a menudo asintomáticos. Puede haber dolor óseo o deformidad. - **Laboratorio: Elevación aislada de Fosfatasa Alcalina (FA)** con calcio y fósforo normales. - **Radiografía:** Imagen en "**sal y pimienta**" (mezcla de zonas líticas y blásticas). - **Tratamiento: Bifosfonatos** (si hay síntomas o riesgo de complicaciones).

NOTA CLÍNICA

Diagnóstico diferencial de lesiones en cráneo: - **Enfermedad de Paget:** Imagen moteada (sal y pimienta). - **Mieloma Múltiple:** Lesiones líticas "en sacabocado" (puntos negros definidos).

Tumores Óseos Malignos y Agresivos

1. Osteosarcoma

Es el tumor óseo maligno primario más común. - **Edad:** Distribución bimodal (Adolescentes/adultos jóvenes 15-20 años y adultos >65 años). - **Localización: Metáfisis** de huesos largos (frecuente cerca de la rodilla). - **Radiografía:** Aspecto francamente maligno, heterogéneo, con disrupción cortical y reacción en "sol naciente". - **Tratamiento:** Cirugía radical (a veces preservadora de extremidad) + Quimioterapia.

2. Sarcoma de Ewing (o de Yubin)

- **Edad:** Niños y adolescentes. - **Localización:** Clásicamente en la **Diáfisis** de los huesos largos o en la pelvis. - **Radiografía:** Reacción perióstica en "**telas de cebolla**". - **Biopsia:** Células pequeñas, redondas y azules (aspecto similar a un linfoma). - **Tratamiento:** Quimioterapia (para reducir el tamaño), cirugía y a veces radioterapia. Tiene pronóstico reservado pero mejoría con tratamientos modernos.

3. Tumor de Células Gigantes

- **Edad:** Adultos de 40 a 50 años. - **Localización: Epífisis/Metáfisis** (típicamente fémur distal o tibia proximal, "alrededor de la rodilla"). - **Comportamiento:** Es localmente muy agresivo (rompe cortical e invade partes blandas), aunque generalmente no da metástasis (benigno biológicamente, maligno radiológicamente). - **Tratamiento:** Cirugía (legrado/curetage amplio).

Resumen de Localizaciones Típicas

TABLA 2.11.2: TUMOR VS LOCALIZACIÓN PREFERENTE

TUMOR	LOCALIZACIÓN PREFERENTE	EDAD SUGERIDA
Osteosarcoma	Metáfisis (Rodilla)	Adolescentes / >65 años
Sarcoma de Ewing	Diáfisis	Niños / Adolescentes
Células Gigantes	Epífisis (Rodilla)	40 - 50 años
Osteoma Osteoide	Cortical	Jóvenes

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Si el caso clínico muestra un adolescente con un tumor maligno en la **diáfisis**, marca **Sarcoma de Ewing**. Si el tumor está en la **metáfisis**, marca **Osteosarcoma**.

Temas relacionados:

- **Mieloma Múltiple** (Principal causa de lesiones líticas en adultos mayores).
- **Fracturas** (Complicación frecuente de tumores óseos).
- **Hipercalcemia** (Posible hallazgo en tumores malignos o mieloma).

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Un deportista de cuarenta años va corriendo y siente súbitamente como una pedrada intensa en el talón. No puede caminar. La maniobra de Thompson está alterada. ¿Cuál es el diagnóstico y el tratamiento?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Lesiones de Partes Blandas. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Las contusiones, desgarros y hematomas se tratan con frío o calor local más AINEs; los hematomas grandes o infectados se drenan quirúrgicamente.
- Los esguinces se clasifican en grado uno sin rotura, grado dos con rotura parcial y grado tres con rotura total con inestabilidad.
- El tratamiento de los esguinces es RICE más AINEs; los grados dos y tres se inmovilizan con órtesis removible; la cirugía es excepcional.
- El quiste de Baker o poplíteo es un quiste sinovial en la fosa poplíteica; si se rompe simula una TVP; el tratamiento es observación o punción.
- La rotura del tendón de Aquiles es degenerativa y se presenta con el síntoma del piedrazo: dolor súbito muy intenso al correr como una pedrada en el talón.
- La maniobra de Thompson evalúa el tendón de Aquiles: al comprimir los gastrocnemios el pie no hace flexión plantar si el tendón está roto.
- La rotura del tendón de Aquiles requiere cirugía urgente antes de que los gastrocnemios se retraigan.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (LESIONES DE PARTES BLANDAS)

PREGUNTA 1

Un deportista de cuarenta años va corriendo y siente súbitamente como una pedrada intensa en el talón. No puede caminar. La maniobra de Thompson está alterada. ¿Cuál es el diagnóstico y el tratamiento?

- A)** Esguince de tobillo grado tres; inmovilización con bota removible
- B)** Rotura del tendón de Aquiles; cirugía urgente
- C)** Rotura del tendón de Aquiles; inmovilización con yeso
- D)** Fractura de calcáneo; radiografía de pie
- E)** Desgarro muscular de gemelos; RICE y AINEs

PREGUNTA 2

Un paciente tiene dolor y edema en la pantorrilla izquierda. Refiere que desde hace varios meses tenía un bulto indoloro en la zona posterior de la rodilla que ahora desapareció. ¿Cuál es el diagnóstico y el tratamiento?

- A)** TVP; ecodoppler y anticoagulación urgente
- B)** Quiste de Baker roto; analgesia con AINEs
- C)** Quiste de Baker roto; cirugía de extirpación urgente
- D)** Hematoma de pantorrilla; frío local y AINEs
- E)** Esguince de rodilla; inmovilizador y AINEs

PREGUNTA 3

Un paciente sufre un esguince de tobillo por inversión y presenta equimosis lateral más inestabilidad articular al examen. ¿Cuál es el grado y el tratamiento?

- A)** Grado uno; solo analgesia sin inmovilización
- B)** Grado dos; RICE más inmovilización con órtesis removible
- C)** Grado tres; RICE más inmovilización con órtesis removible
- D)** Grado tres; cirugía de reparación ligamentaria urgente
- E)** Grado uno; RICE sin necesidad de radiografía

RESUMEN: LESIONES DE PARTES BLANDAS

Las lesiones de partes blandas incluyen contusiones, desgarros musculares, hematomas, esguinces, quiste de Baker y rotura del tendón de Aquiles. El tratamiento de base de la mayoría es frío o calor local más AINEs, con algunas excepciones importantes. Las contusiones son lesiones traumáticas de partes blandas sin fractura; se diagnostican clínicamente y con radiografía para descartar fractura. Los desgarros musculares se producen durante el ejercicio o el estiramiento; el diagnóstico es clínico y el tratamiento es conservador. Los hematomas son colecciones de sangre que se drenan quirúrgicamente si son muy grandes o se infectan. Los esguinces son lesiones ligamentosas clasificadas en grado uno sin rotura, grado dos con rotura parcial y grado tres con rotura total. El grado uno tiene solo dolor, el dos tiene equimosis, el tres tiene inestabilidad articular. El tratamiento agudo es el RICE: reposo, hielo, compresión y elevación, más AINEs. Los grados dos y tres se inmovilizan con órtesis removible. La cirugía de reparación es muy rara y se indica solo cuando hay inestabilidad persistente en el tiempo. El quiste de Baker o quiste poplíteo es un quiste con líquido sinovial en la fosa poplíteica. Habitualmente es asintomático y de observación. Si se rompe produce dolor y edema en la pierna similar a la TVP, pero el antecedente del quiste previo ayuda a diferenciarlo. El tratamiento es observación o punción; la cirugía es excepcional. La rotura del tendón de Aquiles es una lesión degenerativa en adultos con el síntoma del pedrazo: dolor súbito muy intenso como una pedrada en el talón al correr. La maniobra de Thompson está alterada. El tratamiento es quirúrgico urgente antes de que los gastrocnemios se retraigan.